EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 67321
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-07-12 12:49:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: EDITH NELLY MEDINA BUSTOS			RUN	: 6.655.481-3
F.Nac	: 04-07-2023	Edad	: 0 AÑO	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: CHILLAN
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 10-07-2023	Fecha Egreso	: 2023-07-12 12:49:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACV isquémico territorio superficial anterior ACA y ACM izquierdos, etiología cardioembolica, con TH PH-1 fronto-opercular. Trombolisis farmacológica 4/7/23
-Obs flutter auricular
-Bronquitis bacteriana aguda resuelta

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente ingresó por compromiso de conciencia subito, recuperó con alteracion del lenguaje y hemiparesia derecha. Traída a SU HSC, TC cerebro mostró infartohiperagudo frontoinsular izquierdo, se realizó trombolisis con TNK 0.25 mg/kg. Ingresó a UTI, presentó episodios de flutter auricular 1 episodio de bronquitis aguda sin alteracion ventilatoria. Se mantiene estable en deficit neurologico (plejia y afasia), con buena evolución de PA y mejor control de glicemias. Se traslada a sala

Evolución
Paciente BEG, HDN estable, eupneica, afebril, RS al monitor, estable en lo neurológico, se observa tranquila y cooperadora, impresiona sin dolor, tolera bien alimentación por SNG (mantiene tos con papilla), logra sedestación estable y bipedestación con 1 operador y andador, tos muy ocasional sin disnea ni aumento del trabajo ventilatorio.
Completó tto ATB por bronquitis aguda, con buena rpta.
TC cerebro s/c de control muestra extensa lesion isquémica subaguda en territorio superficial anterior de ACM y ACA izq, con TH cortical tipo HSA y PH-1 fronto-opercular. Se decide no iniciar AAS por estas lesiones.
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio hoy, continuar rehabilitación con HODOM y control ambulatorio en policlínico de Neurología.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio hoy
-Continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica con HODOM
-Control ambulatorio en policlínico de Neurología en 10-12 días

INDICACIONES AL ALTA

1. -Losartan 50 mg c/12h
2. -Bisoprolol (2.5 mg) 1/2 comp al día

3. -Atorvastatina (40 mg) 2 comp/noche
4. -Sertralina (50 mg) 1 comp/día AM

OBSERVACIONES:

Ex fco general
-Perfusión e hidratación N, yug no ingurgitadas, rash(-), petequias(-)
-Cardiaco: RR 2T s/s
-Pulmonar: MP(+), SRA, sin uso de musculatura accesoria
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas ni visceromegalia
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos+/+

Ex neurológico
-Mental: vigil, reactiva al medio, sigue con la mirada, emite sonidos ininteligibles, no repite ni nomina, comprende órdenes simples verbales y principalmente por imitación, impresiona ánimo pseudobulbar, resto n/e
-PC: hemianopsia derecha por amenaza, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC derecha leve, disartria leve, sensibilidad facial tactil N, nistagmo(-), úvula central y lengua centrales, resto n/e
-Motor: BC derecho M0, BC izq M5, RCP extensor derecho y flexor izquierdo
-Sensitivo: algesia impresiona conservada en las 4 EE
-Cerebelo: n/e
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO